

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய நுரையீரல் ரத்த அழுத்தம்!

பாதிப்பும்.. சிகிச்சைமுறைகளும்...

மாரடைப்பு, ரத்த அழுத்தம் பற்றி கேள்விப்பட்ட நமக்கு, இதயத்திலிருந்து நுரையீரலுக்குச் செல்லும் ரத்தக் குழாய்களில் ஏற்படும் உயர் ரத்த அழுத்தம் பற்றிப் பெரிய அளவில் தெரிந்திருப்பதில்லை. இதுவே மருத்துவ உலகில் 'பல்மோனரி ஹைபர்டென்ஷன்' (Pulmonary Hypertension) எனப்படுகிறது.

பொதுவாக, உடலின் ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் தோன்றும் ரத்த உறைவு, ரத்த ஓட்டத்தின் வழியாக நுரையீரலுக்குச் சென்று அடைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். பெரும்பாலான நேரங்களில் மருந்துகள் மூலம் இந்த உறைவு கரைந்துவிடும். ஆனால், சிலருக்கு இந்த ரத்த உறைவு முழுமையாகக் கரைவதில்லை. நாளடைவில் இது தழும்பு போன்ற கடினமான திசுவாக மாறி, நுரையீரலின் ரத்தக் குழாய் சுவர்களோடு ஒட்டிக்கொள்ளும். இதனால் ரத்தக் குழாய்கள் சுருங்கி அல்லது அடைபட்டு, இதயத்தின் வலது பகுதி நுரையீரலுக்கு ரத்தத்தை செலுத்தப் பெரும் சிரமத்தை சந்திக்கிறது. இதன் காரணமாக உருவாவதுதான் CTEPH எனப்படும் 'க்ரோனிக் த்ரோம்போஎம்பாலிக் பல்மோனரி ஹைபர்டென்ஷன்' பாதிப்பு.

இது குறித்து விளக்குகிறார் சென்னை கிரீம்ஸ் ரோடு அப்பல்லோ மருத்துவமனையின் மூத்த இதய நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மற்றும் எம்.சி.எஸ் நிபுணர் டாக்டர் பிரகாஷ் எம் லாதானி.

அறிகுறிகளும் ஆபத்துக் காரணிகளும்!

நுரையீரலில் ரத்த உறைவு அடைப்பு ஏற்பட்ட பிறகு, பலருக்கும் வழக்கத்திற்கு மாறான மூச்சுத்திணறல் தொடரலாம். இதோடு தீவிர சோர்வு, உடற்பயிற்சி செய்ய முடியாமை, நெஞ்சு அசௌகரியம், தலைசுற்றல் அல்லது மயக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் தென்படும். 'பல்மோனரி எம்போலிசம்' பாதிப்புக்கு பிறகும் மூச்சுத்திணறல் நீடித்தால், உடனே அதை கவனிக்க வேண்டும்.

முன்பு 'டீப் வெயின் த்ரோம்போசிஸ்' (DVT) எனப்படும் ஆழமான நரம்பு ரத்த உறைவு பாதிப்பு இருந்தவர்களுக்கும், இயல்பாகவே ரத்தம் உறையும் தன்மை அதிகம் கொண்டவர்களுக்கும் இந்த ஆபத்து அதிகம். குறிப்பாக, 'ஆன்டிபாஸ்போலிபிட் சிண்ட்ரோம்' (Antiphospholipid Syndrome) எனப்படும் சுயதடைகாப்பு நோய் உள்ளவர்களுக்கு ரத்தம் உறையும் வாய்ப்பு அதிகம் என்பதால், அவர்கள் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

துல்லியமான பரிசோதனைகள்!

இந்த நோயைக் கண்டறிய ஒரே ஒரு பரிசோதனை மட்டும் போதாது. முதற்கட்டமாக 'எக்கோ கார்டியோகிராம்' (Echocardiogram) பரிசோதனை மூலம் நுரையீரல் ரத்த அழுத்த சந்தேகத்தை உறுதிப்படுத்தலாம். அதைத் தொடர்ந்து, 'V/Q ஸ்கேன்' (Ventilation-Perfusion Scan) செய்து நுரையீரலின் எந்தப் பகுதியில் ரத்த ஓட்டம் குறைவாக உள்ளது என்பதைக் கண்டறியலாம்.

மேலும், 'CT பல்மோனரி ஆஞ்சியோகிராஃபி' மூலம் நுரையீரல் ரத்தக் குழாய்களின் தெளிவான பிம்பங்களைப் பெற முடியும். இறுதியாக, 'ரைட் ஹார்ட் கேத்தடரைசேஷன்' (Right-Heart Catheterisation) பரிசோதனை மூலம் ரத்த அழுத்தத்தின் துல்லியமான அளவைக் கணித்து, பாதிப்பை முழுமையாக உறுதிப்படுத்தலாம்.

முழுமையான குணமளிக்கும் அறுவை சிகிச்சை

பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் செய்தி என்னவென்றால், CTEPH நோய் முற்றிலும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாகும். அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள ரத்தக் குழாய்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடிய பகுதியில் இருந்தால், 'பல்மோனரி எண்டார்டெரெக்டமி' (PEA - Pulmonary Endarterectomy) என்ற சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை மூலம் அடைப்பை ஏற்படுத்திய உறைவை அகற்றி, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்க முடியும்.

